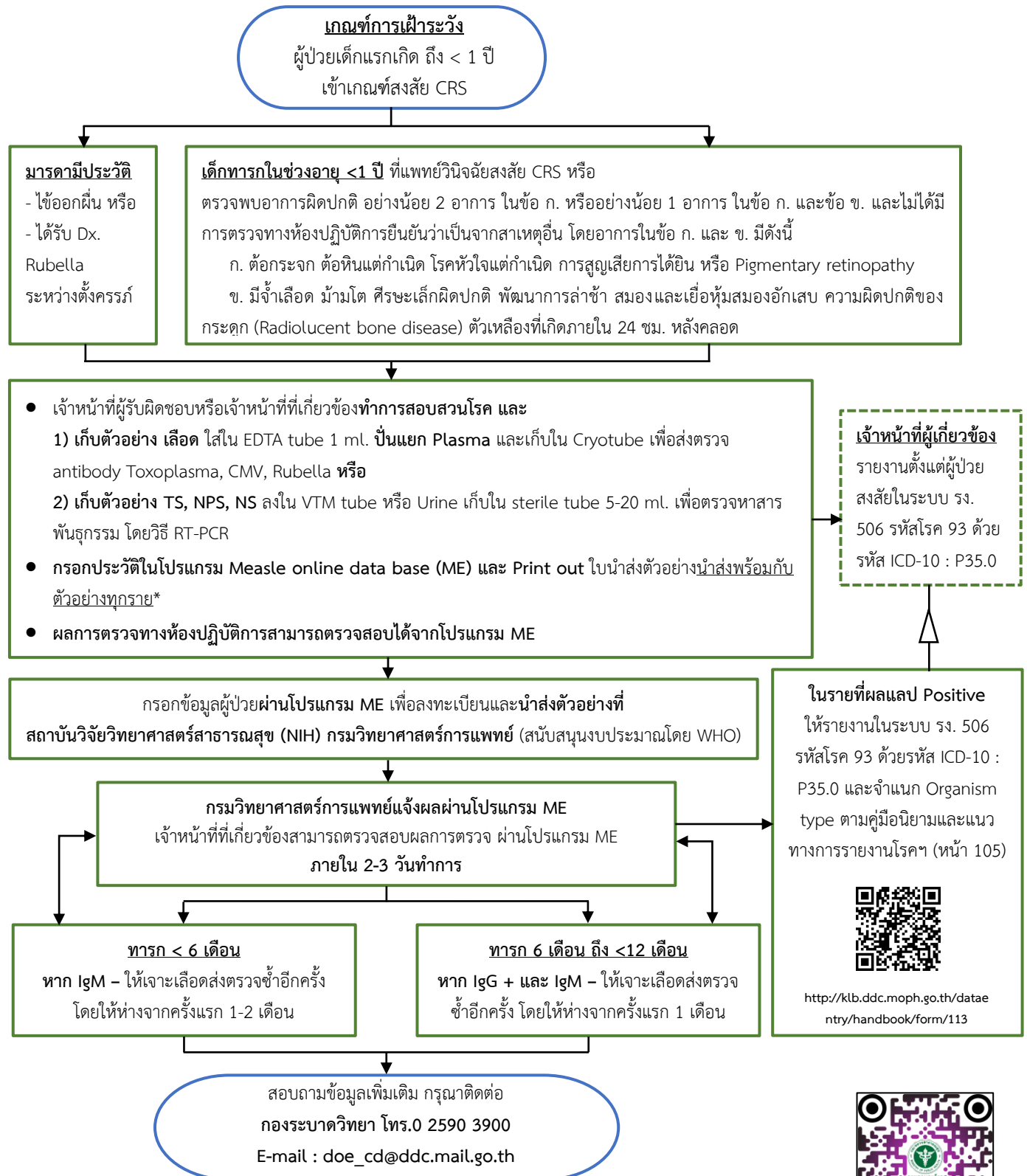


แนวทางการเฝ้าระวังเชื้อก่อโรค
โรคหัดเยอรมันแต่กำเนิด (Congenital Rubella Syndrome)
(สำหรับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทางห้องปฏิบัติการ)

CRS.



หมายเหตุ : 1. ให้เก็บตัวอย่างไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2-8 °C (ไม่ Freeze) ก่อนนำส่งตัวอย่าง เพื่อให้ได้ผลที่ถูกต้องแม่นยำควรส่งตัวอย่างภายใน 48 ชั่วโมง

2. *หากโรงพยาบาลไม่ได้กรอกข้อมูลประวัติผู้ป่วยในโปรแกรม Measle online data base (ME) และ Print out ใบนำส่งตัวอย่างนำส่งมาพร้อมกับตัวอย่าง จะทำให้เกิดความล่าช้าในการตรวจวิเคราะห์

<https://apps-doe.moph.go.th/measles/>

CRS.

No.

แบบส่งตัวอย่างวินิจฉัยเชื้อก่อโรค
โรคหัดเยอรมันแต่กำเนิด (Congenital Rubella Syndrome)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เลขที่ 88/7 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-9510000 ต่อ 99312, 98451

โดยให้เจ้าหน้าที่เวชกรรม หรือ เจ้าหน้าที่ระบาดวิทยา หรือ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง กรอกข้อมูลประวัติ
ของผู้ป่วยทุกรายในโปรแกรม Measle online data base (ME) และ Print out ใบนำส่งตัวอย่าง
นำส่งพร้อมกับตัวอย่างทุกราย



<https://apps-doe.moph.go.th/measles/>

หมายเหตุ : โรงพยาบาลสามารถขอ Username และ Password ไปยังกองระบาดวิทยา
โทร. 0 2590 3900
E-mail : doe_cd@ddc.mail.go.th

แนวทางการเก็บตัวอย่างโรคหัดเยอรมันแต่กำเนิด (Congenital Rubella Syndrome)

1. นิยามผู้ป่วยเฝ้าระวัง

ผู้ป่วยเด็กแรกเกิด – 12 เดือน เข้าเกณฑ์สงสัย CRS

- **มารดามีประวัติ**
 - ไข่ออกฝิ่น หรือ
 - ได้รับการวินิจฉัยว่า ติดเชื้อหัดเยอรมันระหว่างตั้งครรภ์
- **เด็กทารกในช่วงอายุ <1 ปี** ได้รับการวินิจฉัยสงสัย CRS (เกณฑ์ทางคลินิก)
เด็กทารกในช่วงอายุต่ำกว่า 1 ปี ที่ตรวจพบอาการผิดปกติ อย่างน้อย 2 อาการ ในข้อ ก. หรืออย่างน้อย 1 อาการ ในข้อ ก. และข้อ ข. และไม่ได้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันว่าเป็นจากสาเหตุอื่น โดยอาการในข้อ ก. และ ข. มีดังนี้
 - ก. ต้อกระจก ต้อหินแต่กำเนิด โรคหัวใจแต่กำเนิด เช่น PDA, Peripheral PS, ASD, VSD, AVSD การสูญเสียการได้ยิน หรือ Pigmentary retinopathy
 - ข. มีจ้ำเลือด ม้ามโต ศีรษะเล็กผิดปกติ พัฒนาการล่าช้า สมอและเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ความผิดปกติของกระดูก (Radiolucent bone disease) ตัวเหลืองที่เกิดภายใน 24 ชั่วโมงหลังคลอด

2. แนวทางการเก็บตัวอย่าง

- คำแนะนำในการเก็บตัวอย่างเลือด ใส่ใน EDTA tube 1 ml. ปั่นแยก Serum และเก็บใน Cryotube ในเด็กสงสัยป่วย ให้พิจารณาดังนี้
 - เด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ให้เจาะเลือดส่งตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ หากให้ผล IgM เป็นลบ ให้เจาะเลือดส่งตรวจซ้ำอีกครั้ง โดยให้เจาะเลือดห่างจากครั้งแรก 1-2 เดือน
 - เด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือน และไม่เกิน 12 เดือน ให้เจาะเลือดส่งตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ หากให้ผล IgG เป็นบวกและผล IgM เป็นลบ ให้เจาะเลือดส่งตรวจซ้ำอีกครั้ง โดยให้เจาะเลือดห่างจากครั้งแรก 1 เดือน
- หรือเก็บตัวอย่าง Throat swab, Nasopharyngeal swabs, Nasal swabs ลงใน VTM tube หรือ Urine เก็บใน sterile tube 5-20 ml. เพื่อตรวจหาสารพันธุกรรม โดยวิธี RT-PCR
- ให้เก็บตัวอย่างไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศา (ไม่ต้องแช่แข็ง) ก่อนนำส่งตัวอย่าง เพื่อให้ได้ผลที่ถูกต้อง แม่นยำควรส่งตัวอย่างภายใน 48 ชั่วโมง
- การบรรจุตัวอย่างพร้อมส่ง
 - กรอกข้อมูลประวัติผู้ป่วยในโปรแกรม Measle online data base (ME) และ Print out ใบนำส่ง ตัวอย่างนำส่งมาพร้อมกับตัวอย่างทุกราย (1 ใบต่อผู้ป่วย 1 ราย) ให้ชัดเจนและครบถ้วน*

- ใส่ภาชนะที่เก็บตัวอย่างในถุงพลาสติกปิดปากให้แน่น ใส่ในน้ำแข็งที่มากเพียงพอในกล่องโฟม เพื่อให้ตัวอย่าง มีคุณภาพเหมาะสมกับการตรวจมากที่สุดจนถึงปลายทาง ส่งตัวอย่างพร้อมใบนำส่งตัวอย่าง (ห้ามใส่ใบนำส่งตัวอย่างไว้ในกล่องโฟม)

- ระบุข้อความหน้ากล่องตัวอย่างนำส่ง ดังนี้

ตัวอย่างเชื้อก่อโรคหัดเยอรมันแต่กำเนิด (Congenital Rubella Syndrome : CRS)

(โครงการกำจัดหัด หัดเยอรมัน และหัดเยอรมันแต่กำเนิด)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ที่เลขที่ 88/7 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02-9510000 ต่อ 99312, 98451

3. การรายงานผู้ป่วยตามระบบเฝ้าระวังโรค

ให้รายงานตั้งแต่พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ทางคลินิก หรือแพทย์สงสัยหัดเยอรมันแต่กำเนิด และให้เก็บตัวอย่างตรวจยืนยันเพื่อหาภูมิคุ้มกันชนิด IgM ต่อเชื้อหัดเยอรมันในเลือด ด้วยวิธี ELISA หรือหาสารพันธุกรรมของเชื้อหัดเยอรมัน ด้วยวิธี PCR ที่ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทุกราย โดยรายงานผ่านทางฐานข้อมูลโครงการกำจัดหัด (<https://apps-doe.moph.go.th/measles/>) รวมทั้งรายงานผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยด้วยรหัส 93 เข้าสู่ระบบ รง.506 (ICD-10 รหัส P35.0) และในรายที่ IgM + จำแนก Organism type ด้วย

4. การสอบสวนโรค

4.1. สอบสวนเฉพาะราย (Case Investigation) กรณีพบผู้ป่วยสงสัยทุกราย ให้ดำเนินการเก็บตัวอย่างตรวจยืนยันอย่างเหมาะสม ดังนี้

4.1.1 เก็บตัวอย่างซีรัมทันที ในกรณีที่เด็กมีอาการเข้าได้กับผู้ป่วยสงสัยเพื่อตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อโรคหัดเยอรมันชนิด IgM หากผลเลือดเป็นลบในครั้งแรก ให้พิจารณา ดังนี้

- กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน และแพทย์ยังสงสัยหัดเยอรมัน ให้เจาะเลือดซ้ำอีกครั้งห่างกันอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อตรวจหา IgM

- กรณีเด็กอายุระหว่าง 6 เดือน - ต่ำกว่า 12 เดือน ให้เจาะเลือดเพื่อตรวจหาภูมิคุ้มกันชนิด IgG หากผลเลือดเป็นบวก ให้เก็บตัวอย่างเลือดซ้ำเพื่อตรวจภูมิคุ้มกันชนิด IgG ครั้งที่สอง โดยให้เก็บตัวอย่างห่างกันอย่างน้อย 1 เดือน

4.2. สอบสวนการระบาด (Outbreak Investigation)

- ไม่มี

5. หมายเหตุ (Remarks)

- ระยะฟักตัวของโรคไม่ชัดเจน เนื่องจากเป็นการติดเชื้อขณะอยู่ในครรภ์มารดา

- โรคหัด...

- โรคหัดเยอรมันแต่กำเนิดเป็นโรคที่ต้องควบคุมตามพันธสัญญานานาชาติ ภายใต้โครงการ Measles and rubella elimination and congenital rubella syndrome control ที่องค์การอนามัยโลก และประเทศสมาชิก รวมถึงประเทศไทยได้ร่วมกันดำเนินการมา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้มีผู้ป่วยโรคหัดเยอรมันแต่กำเนิดในประเทศไทย ต่ำกว่าจำนวนผู้ป่วยในปี 2553 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ดังนั้น นโยบายการเฝ้าระวังจึงมีความไวสูงเพื่อให้สามารถ ตรวจจับผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว เพื่อการสอบสวนและควบคุมโรคที่ทันเวลาป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง

- เนื่องจากทารกที่ป่วยด้วยหัดเยอรมันแต่กำเนิด สามารถแพร่กระจายเชื้อจากสารคัดหลั่งได้จนถึงอายุ ประมาณ 1 ปี ดังนั้น องค์การอนามัยโลกจึงแนะนำให้มีการเก็บตัวอย่างในผู้ป่วยยืนยันหัดเยอรมันแต่กำเนิด เพื่อติดตามการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส โดยควรเก็บตัวอย่างจากสารคัดหลั่ง เช่น Throat swab/Nasal swab/Urine จนผลการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อให้ผลเป็นลบติดต่อกันอย่างน้อย 2 ครั้ง ในช่วงเวลาห่างกัน 1 เดือน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ กองระบาดวิทยา โทร. 0 2590 3900

E-mail : doe_cd@ddc.mail.go.th

หมายเหตุ *หากโรงพยาบาลไม่ได้กรอกข้อมูลประวัติผู้ป่วยในโปรแกรม Measle online data base (ME) และ Print out
ใบนำส่งตัวอย่างนำส่งมาพร้อมกับตัวอย่าง จะทำให้เกิดความล่าช้าในการตรวจวิเคราะห์

แบบสอบสวนโรคหัดเยอรมันแต่กำเนิด (Congenital rubella syndrome)

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง)
 เลขที่บัตรประชาชน □ - □□□□ - □□□□□ - □□ - □ อายุ ปี เดือน เพศ □ ชาย □ หญิง
 HN AN อาชีพ
 ศาสนา สัญชาติ หมายเลขโทรศัพท์
 ที่อยู่ขณะป่วย บ้านเลขที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ซอย
 ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด
 ภูมิลำเนา เป็นที่อยู่เดียวกับที่อยู่ขณะป่วยหรือไม่ □ ใช่ □ ไม่ใช่ ระบุ
 บ้านเลขที่ หมู่ที่ หมู่บ้าน/ชุมชน ซอย
 ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด
 ชื่อ-สกุลมารดา เลขที่บัตรประชาชน □ - □□□□ - □□□□□ - □□ - □
 อายุ ปี จำนวนการตั้งครรภ์ก่อนหน้านี้
 ฝากครรภ์หรือไม่ □ ไม่ฝาก □ ฝาก ระบุสถานที่ฝากครรภ์ สถานที่คลอดครั้งนี้
 อายุครรภ์ของมารดาตอนคลอด สัปดาห์ น้ำหนักแรกคลอด กรัม APGAR score

2. อาการและอาการแสดง

มีอาการป่วยหรือไม่ □ ไม่มี □ มี

วันที่เริ่มป่วย เวลา น.

การตรวจร่างกายแรกพบ อุณหภูมิร่างกาย องศาเซลเซียส ชีพจร ครั้ง/นาที
 หายใจ ครั้ง/นาที ความดันโลหิต มม.ปรอท

หัวใจพิการแต่กำเนิด □ มี □ ไม่มี □ ไม่ทราบ	มีจ้ำเลือด (purpura) □ มี □ ไม่มี □ ไม่ทราบ
ถ้ามี โปรดระบุชนิด.....	
ตาเป็นต้อกระจก □ มี □ ไม่มี □ ไม่ทราบ	ศีรษะเล็ก (Microcephaly) □ มี □ ไม่มี □ ไม่ทราบ
ต้อหินแต่กำเนิด □ มี □ ไม่มี □ ไม่ทราบ	สมองหรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Meningoencephalitis) □ มี □ ไม่มี □ ไม่ทราบ
Pigmentary retinopathy □ มี □ ไม่มี □ ไม่ทราบ	ตัวเหลือง ตาเหลือง □ มี □ ไม่มี □ ไม่ทราบ
สูญเสียการได้ยิน □ มี □ ไม่มี □ ไม่ทราบ	ภายใน 24 ชั่วโมง
Radiolucent bone disease □ มี □ ไม่มี □ ไม่ทราบ	ม้ามโต □ มี □ ไม่มี □ ไม่ทราบ
อาการผิดปกติอื่น □ มี □ ไม่มี □ ไม่ทราบ	พัฒนาการล่าช้า □ มี □ ไม่มี □ ไม่ทราบ
	ระบุ

3. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

- 3.1 การตรวจทางซีโรโลยี (Rubella IgM) ☐ ไม่ตรวจ ☐ ตรวจ
 สิ่งส่งตรวจ วันที่เก็บตัวอย่าง วันที่ส่งตรวจ
 ผล ห้องปฏิบัติการที่ส่งตรวจ
- 3.2 การตรวจทางซีโรโลยี (Rubella IgG) ☐ ไม่ตรวจ ☐ ตรวจ
 สิ่งส่งตรวจ วันที่เก็บตัวอย่าง วันที่ส่งตรวจ
 ผล ห้องปฏิบัติการที่ส่งตรวจ
- 3.3 วิธีเพาะแยกเชื้อ ☐ ไม่ตรวจ ☐ ตรวจ
 สิ่งส่งตรวจ วันที่เก็บตัวอย่าง วันที่ส่งตรวจ
 ผล ห้องปฏิบัติการที่ส่งตรวจ
- 3.4 วิธี PCR ☐ ไม่ตรวจ ☐ ตรวจ
 สิ่งส่งตรวจ วันที่เก็บตัวอย่าง วันที่ส่งตรวจ
 ผล ห้องปฏิบัติการที่ส่งตรวจ

4. การรักษา

ไปรับการตรวจรักษาครั้งแรกที่ วันที่ เดือน พ.ศ.
 การรักษารั้งนี้: วันที่พบผู้ป่วย เวลา น.
 ประเภทผู้ป่วย ☐ ผู้ป่วยนอก ☐ ผู้ป่วยใน ☐ ผู้ป่วยค้นหาเพิ่มเติมในชุมชน
 ผลการรักษา ☐ กำลังรักษา ☐ หาย ☐ เสียชีวิต ระบุ ☐ ส่งต่อ ระบุ
 สถานที่รักษา วันที่จำหน่าย

5. ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค

5.1 มารดาเคยได้รับวัคซีนป้องกันหัดเยอรมันก่อนตั้งครรภ์หรือไม่ ถ้าเคย ระบุอายุที่เคยได้รับวัคซีน	☐ เคย ☐ ไม่เคย ☐ ไม่แน่ใจ
5.2 มารดาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นหัดเยอรมันในขณะตั้งครรภ์หรือไม่ ถ้ามีระบุอายุครรภ์ตอนได้รับการวินิจฉัย	☐ มี ☐ ไม่มี ☐ ไม่ทราบ
5.3 มารดามีประวัติไข่ออกผื่นระหว่างตั้งครรภ์หรือไม่ ถ้ามีระบุอายุครรภ์ตอนได้รับการวินิจฉัย	☐ มี ☐ ไม่มี ☐ ไม่ทราบ
5.4 มารดามีประวัติไข่ออกผื่นร่วมกับมีต่อมน้ำเหลืองโต และปวดข้อระหว่าง ตั้งครรภ์หรือไม่ ถ้ามีระบุอายุครรภ์ สัปดาห์	☐ มี ☐ ไม่มี ☐ ไม่ทราบ
5.5 มารดาเคยมีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยหัดเยอรมันขณะตั้งครรภ์หรือไม่	☐ มี ☐ ไม่มี ☐ ไม่ทราบ
5.6 มารดาเคยมีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยไข่ออกผื่นขณะตั้งครรภ์หรือไม่	☐ มี ☐ ไม่มี ☐ ไม่ทราบ

6. การค้นหาผู้สัมผัสโรค

มีหญิงตั้งครรภ์ที่สัมผัสกับผู้ป่วยหรือไม่

☐ ไม่มี

☐ มี ระบุชื่อ บ้านเลขที่ อายุ เพศ

☐ ไม่มีอาการป่วย

☐ มีอาการป่วย ระบุอาการ

ผู้ให้ข้อมูล หมายเลขโทรศัพท์

ชื่อผู้สอบสวน ตำแหน่ง

หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด

วันที่สอบสวน หมายเลขโทรศัพท์